

15 - 9 communication en équipe

(0:02 - 0:44)

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous traiter aujourd'hui, lors de ce cours, une situation de communication clinique spécifique dans le domaine médical, c'est la communication en équipe. Les objectifs du cours sont définir une équipe de soins, citer les caractéristiques d'une équipe de soins, citer et décrire les techniques de communication pour les équipes soignantes. Toutes les études récentes confirment que le travail en équipe et particulièrement la qualité de communication constitue une composante majeure dans la sécurité des soins.

(0:45 - 1:21)

Dans un grand centre hospitalier, universitaire par exemple, on compte des équipes de médecins dont chaque spécialité, le personnel infirmier, les pharmaciens ainsi que les autres professionnels paramédicaux qui doivent tous coordonner les soins les uns avec les autres. Donc déjà on introduit ici la notion d'hétérogénéité d'une équipe de soins. Selon les études, la qualité de communication au sein des équipes est minimale.

(1:21 - 1:43)

Seule une partie des informations prioritaires ou importantes est échangée. Elle est inadéquate par une mise en exergue d'informations non importantes, voire erronées. En chirurgie, ce taux s'élève, c'est-à-dire le taux de ces informations minimales et inadéquates, à 32%.

(1:43 - 2:14)

En anesthésie, à 38%. Et entre anesthésistes et chirurgiens, ce taux s'élève à 50%. Dans les pays industrialisés, on estime que 10% des patients sont victimes d'un événement indésirable durant leur séjour à l'hôpital, dont la moitié pourrait être évitée s'il y avait une communication efficace au sein d'une équipe médicale.

(2:16 - 2:53)

De nombreuses études montrent, surtout en anesthésie, qu'une majorité de ces événements est le fruit de défaillances au niveau du travail en équipe. Mauvaise dynamique du groupe, défaut de communication et autres. D'abord, c'est quoi une équipe de soins ? Il s'agit d'une équipe où les membres connaissent leur rôle et les rôles des autres membres et interagissent les uns avec les autres en vue d'atteindre un objectif commun.

(2:55 - 3:21)

Ils prennent des décisions, ils possèdent des connaissances et compétences spécialisées et assument souvent une charge de travail importante. Ils doivent agir comme un individu collectif. Il

existe différents types d'équipes en santé, les centres de soins ruraux, les équipes de salles d'accouchement, les services de soins intensifs et autres.

(3:26 - 3:50)

Ces équipes peuvent être regroupées au même endroit ou dans des lieux différents. Une équipe peut inclure une seule discipline ou impliquer des professionnels issus de plusieurs disciplines différentes. Il faut savoir que le patient et son entourage sont de plus en plus considérés comme des membres actifs de l'équipe soignante.

(3:52 - 4:24)

Les rôles joués par les professionnels de santé varient entre les équipes ou au sein d'une même équipe selon les moments. Cependant, de nombreuses équipes soignantes, tels les équipes d'urgence ou les équipes chirurgicales, doivent travailler ensemble et être parfaitement opérationnelles sans avoir le temps de nouer des relations interpersonnelles. Certaines équipes ne sont pas très stables car leur composition change souvent.

(4:25 - 5:08)

Et en plus, chaque membre de l'équipe a un niveau de connaissance et de compétences différents auquel il faut s'adapter. Quelles sont les caractéristiques d'une équipe, mais cette fois efficaces ? Ils ont un but commun qui est clairement défini, caractérisé par des intérêts collectifs et un sentiment de responsabilité partagée. Ils ont des objectifs mesurables axés sur la tâche de l'équipe et un leadership efficace qui fixe et maintient les structures, gère les conflits, il est à l'écoute des membres, il leur fait confiance, il leur apporte son soutien.

(5:15 - 5:41)

Une équipe efficace a des méthodes de communication efficaces aussi. C'est le partage d'informations qui se fait de façon rapide et régulière et en consacre du temps à la réflexion en équipe. Une bonne cohésion avec un engagement et esprit d'équipe et un respect mutuel.

(5:46 - 6:18)

De bonnes compétences de communication sont les piliers de la sécurité des patients et d'un bon travail d'équipe. Les stratégies suivantes peuvent aider les membres de l'équipe à partager précisément les informations entre eux et à garantir que l'accent soit bien mis sur les informations importantes à communiquer. La méthode S A E D, S pour situation, A antécédent, E évaluation et D demande.

(6:19 - 6:51)

C'est une technique qui permet de communiquer les informations essentielles sur les

préoccupations à l'égard d'un patient qui nécessite une prise en charge et un traitement immédiat, c'est-à-dire en situation d'urgence. S, quelle est la situation actuelle en ce qui concerne le patient. Exemple, je suis l'infirmière qui suit madame X, salle X, lit numéro X. Elle se plaint principalement d'une dyspnée d'apparition récente.

(6:54 - 7:18)

A pour les antécédents, quels sont les antécédents utiles mais qui sont liés au contexte. La patiente est une femme de 62 ans, premier jour post-opératoire après une chirurgie abdominale, elle ne présente aucun antécédent de maladie cardiaque ou pulmonaire. Là vous avez vu que l'infirmière a regroupé les antécédents les plus importants pour la patiente.

(7:19 - 7:37)

E pour évaluation, quelle est mon évaluation de l'état actuel de la patiente. Donc l'examen montre que les bruits respiratoires sont diminués du côté droit et que la patiente dit avoir mal. J'aimerais éliminer un pneu motoraxe qui est une urgence.

(7:40 - 7:53)

D, quelle est ma demande. Je crois vraiment que la patiente doit être examinée maintenant, pouvez-vous venir immédiatement. Deuxième technique, c'est les annonces.

(7:54 - 8:34)

Les annonces sont le moyen de communiquer les informations importantes ou les critiques à tous les membres de l'équipe simultanément lors de situations nouvelles. Cette technique aide les membres de l'équipe à anticiper les étapes suivantes. Exemple, annonce entre un chef d'équipe et un interne.

Chef d'équipe, voie aérienne interne, voie aérienne dégagée. Chef d'équipe, bruit respiratoire interne, bruit respiratoire diminué côté droit, etc. Troisième technique, c'est la communication en boucle fermée.

(8:34 - 8:57)

C'est une technique simple pour garantir que les informations énoncées par l'expéditeur soient bien compris par le destinataire. Étape 1, l'expéditeur initie le message. Étape 2, le destinataire accepte le message et on en répète le contenu.

(8:58 - 9:14)

Étape 3, l'expéditeur vérifie l'exactitude du message répété pour confirmer qu'il a été bien compris. Exemple, le médecin administrait 20 mg de prédnisolone en bolus intraveineux. L'expéditeur initie le message.

(9:15 - 10:23)

L'infirmière, 20 mg de prédnisolone en bolus IV Le destinataire accepte le message, il le répète. Médecin, oui. Donc c'est la troisième étape, l'expéditeur vérifie l'exactitude du message répété pour confirmer qu'il a été bien compris.

La résolution des désaccords et des conflits. Les conflits et les désaccords sont très fréquents chez les équipes soignantes pour toutes les raisons qu'on a citées tout à l'heure et la première cause, c'est l'hétérogénéité des rôles et l'ambiguïté des rôles, parfois, de certains membres de l'équipe. Donc la résolution des accords est délicate pour les membres les moins expérimentés de l'équipe, tels que les étudiants ou dans des équipes qui sont connues par le fait d'être très hiérarchisées par nature, c'est-à-dire qu'ils adoptent une relation de communication asymétrique.

(10:24 - 10:59)

Il est toutefois important que tous les membres de l'équipe se sentent libres de signaler tout élément qui peut, selon eux, avoir une incidence sur la sécurité du patient. Comment on peut résoudre les désaccords et les conflits ? Je vous ai choisi la méthode DESC, c'est un processus constructif de résolution de conflits. L'objectif est de parvenir à un consensus DES, pour décrire la situation ou le comportement spécifique et fournir les données ou les éléments de preuves concrets.

(11:01 - 11:22)

E, exprimer son ressenti face à la situation ainsi que ses préoccupations. S, suggérer des alternatives et rechercher un accord. Essay, les conséquences doivent être énoncées en termes d'effet sur les objectifs définis de l'équipe et ou la sécurité des patients.

(11:26 - 11:47)

La méthode CUS est l'abréviation désignant un processus en trois étapes visant à aider une personne à mettre fin à une activité problématique. C, I'm concerned, je suis préoccupé. U, I'm uncomfortable, je suis très mal à l'aise par rapport à la situation.

(11:48 - 12:08)

This is a safety issue, c'est une question de sécurité. En conclusion, développer le savoir-faire du travail ou de l'équipe où la communication s'inscrit en première ligne contribue fortement à l'amélioration des sécurités des soins. Je vous remercie.